

· 指南研究 ·

《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》推荐
意见专家共识周英凤¹, 章孟星¹, 李 丽², 钟 婕¹, 潘秀红³, 赵杏珍⁴, 郭娜菲⁵

(1. 复旦大学护理学院 复旦大学 JBI 循证护理合作中心, 上海 200032; 2. 复旦大学附属妇产科医院; 3. 复旦大学附属浦东医院; 4. 上海市嘉定区妇幼保健院; 5. 上海市第一妇婴保健院)

Expert consensus study on recommendations of clinical nursing practice guidelines for gestational diabetes mellitus**ZHOU Yingfeng, ZHANG Mengxing, LI Li, ZHONG Jie, PAN Xiuhong, ZHAO Xingzhen, GUO Nafei**

(School of Nursing, Fudan University, Fudan University Center for Evidence-based Nursing; a JBI Center of Excellence, Shanghai 200032 China)

摘要: [目的] 对《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案中推荐意见的内容和推荐强度达成共识。[方法] 通过目的抽样法, 纳入 13 名临床专家和方法学专家, 采用共识形成会议法结合定量论证的方法, 就指南中的推荐意见及推荐强度达成共识。[结果] 通过共识形成会议法, 最终删除 8 条推荐意见, 对 7 条推荐意见进行了修改, 最终纳入 69 条推荐意见。经过专家定量论证, 57 条推荐意见为强推荐, 12 条推荐意见为弱推荐。[结论] 共识形成会议法和专家定量论证为指南推荐意见达成共识提供了决策建议和决策依据, 最终纳入的推荐意见具有较好的临床适用性。

关键词: 妊娠期糖尿病; 临床护理; 指南; 推荐意见; 专家共识; 产前管理; 分娩期管理; 新生儿管理; 产后管理

Abstract Objective: To reach expert a consensus on the content and strength of recommendations in the draft of *Guidelines for Clinical Nursing Practice of Gestational Diabetes*. **Methods:** By using the purposive sampling method, a total of 13 clinical experts and methodological experts were included. The consensus formation meeting method combined with the method of quantitative argumentation was used to reach a consensus on the recommendations and strength of recommendations in the guidelines. **Results:** Through the consensus formation meeting method, 8 recommendations were deleted, 7 recommendations were revised, and 69 recommendations were finally included. After quantitative analysis by experts, 57 recommendations were strong recommendations and 12 recommendations were weak recommendations. **Conclusions:** The consensus formation conference method and expert quantitative argumentation provided suggestions and a basis of decision-making for reaching a consensus on the guideline recommendations, and the final recommendations had good clinical applicability.

Keywords gestational diabetes mellitus; clinical nursing; guidelines; recommendations; expert consensus; prenatal management; childbirth management; neonatal management; postpartum management

中图分类号: R473.71 文献标识码: A doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2020.24.001

妊娠期糖尿病 (gestational diabetes mellitus, GDM) 是孕期常见的并发症之一, 正在形成全球流行的趋势。国际糖尿病联盟 2017 年发布的第 8 版全球糖尿病地图显示^[1], 16.2% 的妊娠期妇女会出现不同程度的血糖升高, 增加了母婴近期及远期不良结局的风险。为了促进妊娠期糖尿病的规范化管理, 近年来, 各个国家及国际组织均制定了基于证据的临床实践指南^[2-3]。中华医学会妇产科学分会产科学组也于 2014 年发布了基于专家共识的《妊娠合并糖尿病诊治指南》^[4], 但在护理领域尚缺乏基于证据的临床护理实践指南。在

此背景下, 本研究团队在妊娠期糖尿病护理管理现状调研的基础上^[5], 以 ADAPTE 指南整合方法作为方法学指导^[6], 通过系统检索和评鉴妊娠期糖尿病相关的临床实践指南和系统评价, 遴选与妊娠期糖尿病护理相关的最佳证据, 整合形成《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案。该指南包括妊娠期糖尿病的诊断、产前护理、分娩期护理、新生儿护理、产后护理 5 个部分, 针对 21 个健康问题初步拟定了 77 条推荐意见。但如何依据现有的证据、权衡利弊并综合考虑病人意愿, 就推荐意见的内容和推荐强度达成一致, 是指南构建过程中重要的一步。因此, 本研究旨在通过专家共识法, 就研究团队构建的《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案中的推荐意见及推荐强度达成一致, 为推动妊娠期糖尿病规范化管理提供指导。

1 资料与方法

本研究采用共识形成会议法结合定量论证的方法

基金项目 2018 年国家自然科学基金面上项目, 编号: 71874035

作者简介 周英凤, 副教授, 博士, E-mail: zyingfeng@fudan.edu.cn

引用信息 周英凤, 章孟星, 李丽, 等. 《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》推荐意见专家共识[J]. 护理研究, 2020, 34(24): 4313-4318.

对《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案中的推荐意见内容和推荐强度达成一致。共识形成会议法是由美国国立卫生研究院提出的,是就某问题根据呈现的证据达成共识的方法^[7],通过遴选1组人(一般10人左右)参加会议,通过面对面讨论,实现快速决策。

1.1 专家选择 遵循专业性、权威性和多学科原则,采用目的抽样法,选取来自上海市4家医疗机构的临床专家及循证方法学专家。临床专家纳入标准:具有本科以上学历、中级及以上职称、5年及以上工作经验并从事与妊娠期糖尿病相关的产科医疗/护理工作。循证方法学专家纳入标准:具有硕士及以上学历及副高及以上职称、接受过循证方法学专业教育、具有5年以上工作经验、参与或主持过临床实践指南的制定。最终共纳入13名专家,其中临床专家8名(包括3名产科医生、1名营养师、4名妊娠期糖尿病专科护士)和方法学专家5名,年龄29~54(40.45 ± 7.79)岁;工作年限(16.64 ± 8.49)年;所有专家均具有硕士及以上学历,10名专家具有副高及以上职称。

1.2 共识形成会议 共识形成会议主要围绕《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案中形成的推荐意见的证据来源是否清晰、推荐意见对妊娠期糖尿病护理管理是否重要、推荐意见是否适合中国临床情景、推荐意见在临床实践中是否可行及推荐意见表述是否确切5个议题展开深入讨论,对存在的争议通过集体决策达成一致。

1.3 定量论证 以《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案为依据,汇总所有推荐意见,形成专家论证表,包括推荐意见描述、证据来源、证据质量、专家意见4个部分。其中推荐意见描述包括所有与妊娠期糖尿病护理管理相关的推荐意见,共77条;证据质量是针对每条推荐意见的证据来源及证据等级;专家意见是由现场参与论证的专家针对每条推荐意见,从推荐意见的利弊判断、推荐意见的成本高低及病人对推荐意见的意愿(该部分数据来自课题组前期的横断面调查)3个方面做出判断。在以上判断的基础上,确定每条推荐意见的推荐强度,推荐强度采用2011版证据质量分级方法(GRADE)系统^[8],包括强推荐、弱推荐两个等级。

1.4 组织与实施 ①共识形成会议:首先与专家联系,确定会议的时间和地点,选择大小合适、有圆形会议桌的会议室,为专家准备纸质版《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》草案。由课题负责人(第一作者)作为会议负责人,由研究团队成员(第二作者)现场记录,在

知情同意下全程录音。首先课题负责人通过播放PPT的形式向专家详细介绍本指南的构建过程和推荐意见的形成过程,然后围绕5个议题展开讨论,鼓励所有专家自由发言,不对专家发言进行评价,不同议题可更改专家发言的顺序,避免受个别专家观点的影响。②定量论证:会议结束后,向专家发放指南推荐意见论证表,专家基于共识形成会议讨论,并结合个人临床经验和判断,分别独立对论证表中推荐意见的等级做出评价,填完后当场回收论证表。

1.5 资料整理与分析 ①共识形成会议:在会议结束后的72 h内,将现场记录和录音整理文字,通过内容分析法对专家的意见进行分析和整理,对指南中推荐意见的内容和表述达成一致。②定量论证:将专家论证表进行编码,采用Microsoft Excel 2003进行数据录入,采用SPSS 23.0进行统计分析,采用频数、百分比对论证结果进行统计描述,采用内部一致性系数(ICC)描述专家之间意见的一致程度,以70%以上专家意见作为推荐意见强度达成的标准,本研究所有推荐意见经过1轮论证已达成共识,故未开展第2轮论证。

2 结果

2.1 共识形成会议讨论结果 针对指南草案中的77条推荐意见,专家一致认为所有推荐意见依据的证据来源清晰,但有8条推荐意见专家建议删除,理由包括“推荐意见对临床实践不重要”“推荐意见不适合临床情景”“推荐意见适合孕前糖尿病而非妊娠期糖尿病”“推荐意见是产科常规而非仅针对妊娠期糖尿病管理”等。如第32条推荐意见“若能保证妊娠期糖尿病孕妇安全,可考虑目标血糖更低:空腹 ≤ 5.0 mmol/L,餐后1 h ≤ 7.4 mmol/L,餐后2 h ≤ 6.4 mmol/L”,专家讨论认为,为确保孕妇和胎儿安全,孕期能够达到目标血糖即可,不需设立过于严格的血糖标准,以免影响母婴安全。因此,建议删除。此外,有7条推荐意见专家建议依据我国临床情景及中国人群标准进行本土化修改,如第1条推荐意见体质指数(BMI) ≥ 30 kg/m²作为妊娠期糖尿病的高危因素,但该标准来自国际指南,并不适用于我国人群特征。因此,依据2篇Meta分析^[9-10]及1篇中国专家共识性指南^[4],将其修改为“BMI ≥ 25 kg/m²”作为中国妊娠期糖尿病病人的高危因素。经过共识形成会议,删除了指南中8条推荐意见,最终纳入69条推荐意见作为专家定量论证的依据。

2.2 专家定量论证结果 13名专家对纳入的69条推荐意见,依据证据质量、病人意愿、利弊判断、成本高低对推荐强度做出选择,专家之间内部一致性系数为

0.87。最终,69 条推荐意见中,57 条推荐意见为强推荐,12 条推荐意见为弱推荐。具体见表 1。

表 1 《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》推荐意见论证结果

单位: %

类别	推荐意见	证据质量	病人意愿	利大于弊	成本低	推荐强度	
						强推荐	弱推荐
GDM 诊断	1 第 1 次产检时,应评估孕妇是否存在 GDM 独立高危因素	中	100.00	100.00	76.92	84.62	15.38
	2 对有 GDM 独立危险因素的孕妇,建议尽早开始非药物干预	中	73.26	84.62	23.08	7.69	92.31
	3 建议所有的孕妇在妊娠 24~28 周进行 75 g 口服葡萄糖耐量(OGTT)检查	高	100.00	100.00	53.85	84.62	15.38
	4 妊娠期 2 h 75 g OGTT 检查符合以下任何 1 项或 1 项以上标准,诊断为 GDM:①空腹静脉血糖值(FPG)5.1~6.9 mmol/L;②服糖后 1 h $\geq$ 10.0 mmol/L;③服糖后 2 h 8.5~11.0 mmol/L	极低		100.00	30.77	76.92	23.08
	5 GDM 诊断的实验室检查应遵循规范的操作程序,正确收集和送检血标本进行血糖检查	极低		100.00	100.00	92.31	7.69
产前管理	6 卫生保健人员应为 GDM 妇女提供以下信息:①GDM 对母亲及胎儿的短期及长期不良影响;②孕期良好血糖控制的益处;③GDM 的干预策略,包括饮食调整、适宜运动,必要时采取药物治疗	极低	94.15	94.15	100.00	100.00	0.00
	7 卫生保健人员应为所有糖尿病妇女提供糖尿病自我管理的指导,包括提供支持性教育课程(涵盖知识教育和技能指导)、个性化指导及提供符合当地文化的教育资料等	极低	81.89	81.89	69.23	84.62	15.38
	8 卫生保健人员应为妇女提供糖尿病自我管理教育与支持时,应以孕妇为中心,尊重孕妇偏好,帮助孕妇做出恰当临床决策	极低	88.02	85.24	100.00	76.92	23.08
	9 卫生保健人员应鼓励所有糖尿病孕妇参与到糖尿病自我管理中,通过多种渠道,获取自我管理的知识和技能,促进孕妇进行良好的自我管理	极低	94.15	81.89	69.23	92.31	7.69
	10 建议所有确诊 GDM 的孕妇转至多学科合作糖尿病专科门诊,接受营养咨询,帮助孕妇正确选择食物的种类和数量	极低	91.09	85.24	38.46	92.31	7.69
	11 卫生保健人员应为所有糖尿病孕妇提供个体化的饮食方案	高	91.09	84.62	69.23	76.92	23.08
	12 卫生保健人员应评估糖尿病孕妇是否有运动禁忌证	极低	88.02	100.00	100.00	84.62	15.38
	13 若无运动禁忌证,建议孕妇进行适当的、有规律的、个体能够适应的运动,孕前规律运动的妇女,可建议怀孕后继续维持适宜的运动	极低	88.02	100.00	100.00	100.00	0.00
	14 建议孕妇保持适宜的运动频率(如每周 3 次或 4 次),以低至中等强度的有氧运动或抗阻力运动为主,避免连续 2 d 或 2 d 以上不运动	中	88.02	100.00	84.62	84.62	15.38
	15 建议孕妇避免久坐,可将长时间(≥ 90 min)的静坐分散	极低	88.02	100.00	100.00	76.92	23.08
	16 糖尿病孕妇给予饮食调整、运动干预 1~2 周后,若空腹或餐前血糖 ≥ 5.3 mmol/L,或餐后 2 h 血糖 ≥ 6.7 mmol/L,或调整饮食后出现饥饿性酮症,增加热量摄入后血糖又超过妊娠期标准者,建议接受药物治疗	极低	73.54	100.00	66.67	92.31	7.69
	17 建议需要药物治疗的糖尿病孕妇优先选择胰岛素	中	73.54	100.00	53.85	92.31	7.69
	18 卫生保健人员根据糖尿病孕妇血糖水平,提供个体化的胰岛素治疗方案	极低	73.54	100.00	69.23	84.62	15.38
	19 对于不依从或拒绝使用胰岛素的糖尿病孕妇,建议选择口服二甲双胍或格列苯脲,使用时应与孕妇讨论,告知可能的风险	高	45.68	100.00	84.62	15.38	84.62
	20 在糖尿病妇女孕期管理过程中,卫生保健人员应对孕妇的精神和社会心理问题(如抑郁)进行筛查,以提供相应照护	极低	79.39	100.00	30.77	7.69	92.31
	21 建议所有糖尿病孕妇进行自我血糖监测,并指导正确的监测方法	高	84.12	100.00	53.85	100.00	0.00
	22 对新诊断的高血糖孕妇、血糖控制不理想孕妇、采用胰岛素治疗的孕妇,建议每日测量血糖 7 次,包括 3 餐前 30 min、3 餐后 2 h 和夜间血糖	极低	75.21	84.62	30.77	7.69	92.31
	23 对血糖控制稳定的孕妇,建议每周至少测量 1 次全天血糖,包括空腹血糖及 3 餐后 2 h 血糖共 4 次	低	84.12	100.00	69.23	92.31	7.69
	24 建议糖尿病孕妇在妊娠期间,定期随访糖尿病产前门诊以评估其血糖控制情况	极低	85.24	100.00	30.77	15.38	84.62
	25 卫生保健人员可通过远程诊疗技术评估孕妇血糖控制情况,并提供自我管理信息	极低	80.78	84.62	53.85	0.00	100.00
	26 对使用胰岛素治疗的孕妇,卫生保健人员应根据血糖测量结果及时调整胰岛素用量	极低	73.54	100.00	84.62	92.31	7.69

(续表)

类别	推荐意见	证据 质量	病人意愿	利大于弊	成本低	推荐强度	
						强推荐	弱推荐
分娩期 管理	27 卫生保健人员应与糖尿病孕妇就孕期目标血糖进行沟通,并强调低血糖的风险	极低	93.04	100.00	84.62	84.62	15.38
	28 应告知GDM孕妇目标血糖:空腹3.3~5.3 mmol/L,餐后1 h≤7.8 mmol/L,餐后2 h 4.4~6.7 mmol/L	中		100.00	84.62	100.00	0.00
	29 应指导GDM孕妇识别并处理低血糖症状,出现低血糖时应立刻进食,推荐摄入15 g单一糖类	高	93.04	100.00	100.00	92.31	7.69
	30 若糖尿病孕妇出现不明原因恶心、呕吐、乏力等不适或血糖控制不理想时,建议其监测尿酮体	极低	88.02	100.00	100.00	100.00	0.00
	31 对疑似酮症酸中毒的孕妇,建议立即接受医疗干预和产科照护	极低	94.99	100.00	100.00	92.31	7.69
	32 不建议常规采用糖化血红蛋白作为评估孕妇血糖控制的指标	极低		84.62	100.00	84.62	15.38
	33 GDM孕妇在确诊时,应检测糖化血红蛋白水平以明确是否存在孕前2型糖尿病	极低	91.09	100.00	84.62	76.92	23.08
	34 卫生保健人员应告知GDM孕妇孕期糖化血红蛋白值<5.5%	极低		100.00	100.00	76.92	23.08
	35 不建议对糖尿病孕妇常规进行连续血糖监测	中		84.62	53.85	7.69	92.31
	36 采用胰岛素治疗的糖尿病孕妇,出现以下任一情况可进行连续血糖监测:①严重低血糖(伴有或不伴有低血糖损害);②血糖水平不稳定者;③需要动态监测血糖变化者	中	73.26	100.00	15.38	23.08	79.62
	37 应为使用连续血糖监测的孕妇提供指导,帮助其掌握连续血糖监测的技能	极低	73.26	100.00	53.85	76.92	23.08
	38 建议糖尿病孕妇在妊娠28~36周,每4周进行1次超声检查;根据临床指证可增加检查次数	高	90.25	100.00	30.77	76.92	23.08
	39 建议GDM孕妇妊娠晚期密切监测胎动。建议使用胰岛素或口服降糖药物者,自妊娠32周起,每周行1次无应激试验(NST)	极低	87.74	69.23	69.23	0.00	100.00
	40 应为糖尿病孕妇提供个体化胎儿监测方式	高	94.15	100.00	30.77	76.92	23.08
	41 卫生保健人员应在妊娠晚期产前检查时,与糖尿病孕妇讨论分娩时间和分娩方式的利弊	极低	85.24	100.00	84.62	100.00	0.00
	42 建议有并发症或血糖管理不佳的糖尿病孕妇选择在具备糖尿病科、产科、新生儿科专业人员的医院分娩	中	100.00	100.00	53.85	84.62	15.38
	43 若糖尿病孕妇分娩时使用全身麻醉,应从全身麻醉开始,30 min监测血糖1次,直至胎儿娩出,产妇完全清醒	高	82.17	84.62	15.38	76.92	23.08
	44 建议糖尿病孕妇在分娩过程中补充足够的热量,以满足其高能量需求	极低	82.17	84.62	84.62	23.08	79.62
	45 糖尿病孕妇分娩期间应1 h监测1次血糖,确保血糖维持在4~7 mmol/L	高	82.17	100.00	84.62	92.31	7.69
	46 对分娩期间血糖不能维持在4~7 mmol/L的糖尿病孕妇,可静脉输注葡萄糖和胰岛素	高	82.17	100.00	69.23	84.62	15.38
新生儿 管理	47 建议糖尿病孕妇选择有24 h新生儿复苏资源及技能的医院分娩	中	100.00	100.00	69.23	84.62	15.38
	48 所有妇产科医院/病区均应有预防、监测和管理糖尿病孕妇新生儿低血糖的书面文件	极低		100.00	69.23	92.31	7.69
	49 妇产科医院/病区应采用可靠的方法监测糖尿病孕妇新生儿的血糖	低		100.00	69.23	100.00	0.00
	50 糖尿病孕妇娩出的新生儿可于出生后1~2 h、4 h以及之后每隔4 h(最好在喂养前)监测新生儿血糖,直到连续3次血糖>2.6 mmol/L	极低	91.09	100.00	69.23	92.31	7.69
	51 若新生儿血糖水平<2.6 mmol/L,建议增加哺乳;若新生儿血糖水平1 h内连续两次<2.6 mmol/L,可转诊到新生儿科;若新生儿任意1次血糖水平≤2.0 mmol/L,应立即转诊到新生儿科	极低	93.31	100.00	69.23	84.62	15.38
	52 在母婴情况稳定时,建议糖尿病孕妇产后应尽快哺乳(30 min内),频繁哺乳(2~3 h哺乳1次)	中	96.94	100.00	100.00	92.31	7.69
	53 对糖尿病产妇产出的新生儿,应密切评估是否存在低血糖临床指征	极低	91.09	100.00	69.23	92.31	7.69
	54 若存在低血糖临床指征,应监测血糖水平,对低血糖婴儿尽快静脉注射葡萄糖	极低	77.99	100.00	84.62	100.00	0.00
	55 若糖尿病产妇产出的新生儿出现低血糖临床指征、新生儿经口喂养无效时,建议使用管饲或静脉输注葡萄糖等方式	中	77.99	100.00	84.62	100.00	0.00

(续表)

类别	推荐意见	证据质量	病人意愿	利大于弊	成本低	推荐强度	
						强推荐	弱推荐
产后管理	56 应为产妇及新生儿提供母婴同室,除非有临床指证表明新生儿需要进监护室或特殊护理	极低	93.31	100.00	100.00	92.31	7.69
	57 若新生儿出现以下情况,建议转入监护室:①低血糖伴有异常临床指证;②呼吸窘迫;③心脏代谢失调指证,提示先天性心脏病,心肌病;④新生儿脑病指证;⑤红细胞增多症且可能需要交换输血;⑥需要静脉输液;⑦需要管饲(除非产后病房能提供充分支持);⑧黄疸需要光疗和频繁监测高胆红素血症;⑨妊娠 34 周前出生,或妊娠 34~36 周出生后经过评估需要入住新生儿监护室	中	93.31	100.00	53.85	100.00	0.00
	58 应将婴儿出生体重、母亲 GDM 史记录在婴儿医疗档案中	极低		100.00	84.62	84.62	15.38
	59 糖尿病孕妇分娩的新生儿未达 24 h、血糖水平未维持在理想状态或喂养情况不佳时,不建议出院	极低	93.31	100.00	100.00	92.31	7.69
	60 建议胰岛素治疗的 GDM 产妇产后降血糖药物根据血糖监测情况酌情减量或停止使用;妊娠期无须胰岛素治疗的 GDM 产妇可恢复正常饮食,但避免高糖及高脂饮食	极低	76.32	84.62	100.00	15.38	84.62
	61 建议 GDM 产妇产后 24 h 监测早餐前(空腹血糖)和餐后 2 h 血糖,若空腹血糖达到 7 mmol/L,或连续 2 次餐后 2 h 血糖 ≥ 11 mmol/L,可转诊至糖尿病专科门诊。若血糖在正常范围内,产后 24 h 后可停止血糖监测	极低	76.32	69.23	84.62	7.69	92.31
	62 应鼓励和支持糖尿病产妇尽可能母乳喂养,至少坚持 6 个月	低	96.94	100.00	100.00	100.00	0.00
	63 对不适合或不愿意母乳喂养的妇女,建议产妇选择婴儿配方奶进行喂养	极低	76.32	84.62	69.23	76.92	23.08
	64 对 GDM 妇女提供产后避孕、发展为 2 型糖尿病风险、健康生活方式等健康教育	高	93.31	100.00	84.62	92.31	7.69
	65 告知有 GDM 史的妇女产后出现糖尿病前期表现时应及时就诊,在专业人员指导下接受生活方式干预或预防性服用二甲双胍	极低	75.21	100.00	100.00	84.62	15.38
	66 应告知糖尿病妇女其子代进行生长发育随访的重要性,并提供健康生活方式的指导	极低	96.38	100.00	100.00	92.31	7.69
	67 GDM 产妇出院前应测量血糖以排除高血糖;并告知合并孕前糖尿病的产妇常规进行糖尿病门诊随访	中	75.21	100.00	100.00	92.31	7.69
	68 建议 GDM 妇女在产后 6~12 周行 2 h 75 g OGTT 以排除糖尿病前期或糖尿病	中	75.21	84.62	69.23	84.62	15.38
	69 若 OGTT 结果正常,建议妇女定期进行糖尿病检查,并在下次妊娠前进行诊断检查	中	88.02	100.00	84.62	84.62	15.38

3 讨论与建议

3.1 共识形成会议法为指南推荐意见达成共识提供了集体决策建议。临床实践指南作为指导医疗、护理实践活动的重要工具和决策依据^[11],从 20 世纪 80 年代在全球范围内开展以来,受到了管理者、实践者和研究者极大的关注。随着指南构建方法学的不断发展,美国医学会(Institute of Medicine, IOM)在 2011 年将指南的定义更新为“综合考虑基于系统评价的证据并权衡不同干预措施的利弊,形成为病人提供最佳保健服务的推荐意见”^[12]。这就意味着从证据到推荐意见转化过程中不仅需要考虑证据本身的有效性,还需要综合权衡推荐意见实施所需要的成本资源以及实施后所带来的利与弊,并结合病人的意愿,综合权衡后做出推荐方向和强度的决定^[13]。因此,国际指南网^[14]建议,需要通过群体共识的方式来选择和解释证据,并将证据

转化为推荐建议。而共识形成会议法是一种常被用于就证据达成共识的正式共识法^[7],针对特定的议题,通过面对面沟通,快速决策。本研究采纳共识形成会议法,针对指南草案中的推荐意见,从证据来源、重要性、适用性、可行性、确切性 5 个方面展开深入讨论,弥补了单纯定量论证的缺陷。

3.2 专家定量论证法为指南推荐意见达成共识提供了决策依据。虽然共识形成会议法为指南推荐意见达成共识提供了集体决策建议,但该方法也有一定的弊端,比如专家间可能相互影响、缺乏量化的决策依据等。因此,在经过共识形成会议定性讨论后,将定量论证的方法融入推荐意见的形成中,可为指南制定小组就推荐意见达成共识提供客观依据。2015 年《中国万古霉素治疗药物监测指南的制订》中^[15],指南构建小组也采用了定量论证的方法进行推荐意见的共识,以某

项选择总票数超过70%视为达成共识,确定推荐方向和推荐强度。因此,本研究结合专家定量论证方法,针对共识形成会议后纳入的推荐意见,从“推荐意见的利弊判断”“推荐意见的成本高低”及“病人对推荐意见的意愿”3个方面做出评价,以此为依据确定推荐意见的推荐强度,将超过70%的专家意见作为确定推荐强度的依据。结果表明,专家之间内在一致性系数较高,经过一轮论证,所有推荐意见均达成了共识。由此可见,定量论证方法具有客观性及量化的特点,为推荐意见的达成提供了客观的数量分析方法,使结果更加直观、具体,便于达成共识。

3.3 推动指南应用于临床实践是下一阶段的研究重点 本指南经过共识形成会议法和专家定量论证后,所达成的推荐意见具有较好的科学性和临床适用性。如第13条证据“若孕妇无禁忌证,建议孕妇进行适当的、规律的、个体能够适应的运动”,虽然该条证据质量为极低,但运动锻炼是妊娠期糖尿病有益的辅助治疗方式,符合病人的意愿,专家普遍认为利大于弊,且成本低,所以一致做出了“强推荐”决议。而第19条证据“对于不依从或拒绝使用胰岛素的孕妇,可建议选择口服二甲双胍或格列本脲”,尽管该条证据质量为高,但是病人对口服降糖药意愿较差,且口服降糖药对胎儿的远期影响尚缺乏证据支持,所以最终经过专家论证为弱推荐。而指南构建的目的在于为临床实践者提供决策依据,根据澳大利亚循证护理中心(Joanna Briggs Institute, JBI)循证卫生保健模式^[16],证据应用是循证实践发展的重要环节。因此,在完成指南从证据到推荐意见转化后,应通过推动指南的临床应用,明确指南的有效性 & 可操作性。所以基于研究团队构建的《妊娠期糖尿病临床护理实践指南》发展具有可操作性的循证实践方案,推动指南推荐意见的应用和转化,是下一阶段的研究重点。

此外,本研究也存在一定的局限性,如仅纳入了上海地区的专家、专家数量偏少等,建议在指南试点应用后,根据应用结果对指南推荐意见修改和完善后,再扩大范围开展专家论证,以增强该指南的可推广性。

参考文献:

- [1] International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas eighth edition [EB/OL]. (2017-12-01) [2019-11-01]. <http://www.diabetesatlas.org/>.
- [2] The International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas ninth edition [EB/OL]. (2019-11-15) [2019-11-30]. <http://www.diabetesatlas.org/>.
- [3] National Institute for Health and Care Excellence. Diabetes in pregnancy: management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period [M]. London: RNOG Press, 2004: 1.
- [4] 中华医学会妇产科学分会产科学组, 围产医学分会妊娠合并糖尿病协作组. 妊娠合并糖尿病诊治指南(2014) [J]. 糖尿病临床, 2014, 8(11): 489-498.
Diabetes and Pregnancy Group of Perinatal Medicine Branch, Obstetric Group of Gynecology & Obstetrics branch of Chinese Medical Association. Guideline of diagnosis and treatment for diabetes and pregnancy (2014) [J]. Diabetes World, 2014, 8(11): 489-498.
- [5] 章孟星, 周英凤, 钟婕, 等. 妊娠期糖尿病专科护士临床实践现状的质性研究 [J]. 护理学杂志, 2018, 33(14): 67-70.
ZHANG M X, ZHOU Y F, ZHONG J, et al. Qualitative research on the clinical practice of specialist nurses in gestational diabetes mellitus [J]. Journal of Nursing Science, 2018, 33(14): 67-70.
- [6] The ADAPTE Collaboration. Guideline adaption: a resource tool-kit [EB/OL]. (2010-03-01) [2019-11-30]. <http://www.g-i-n.net/document-store/working-groups-documents/adaptation/adapte-resource-toolkit-guideline-adaptation-2-0.pdf/view?searchterm=adapte>.
- [7] FINK A, KOSECOFF J, CHASSIN M, et al. Consensus methods: characteristics and guidelines for use [J]. American Journal of Public Health, 1984, 74(8): 979-983.
- [8] The GRADE Working Group. GRADE handbook [EB/OL]. (2013-10-01) [2019-11-01]. <http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html>.
- [9] 刘雪娜, 姜宝法. 妊娠期糖尿病相关因素的 Meta 分析 [J]. 现代妇产科进展, 2012, 21(3): 166-171.
LIU X N, JIANG B F. Meta-analysis of partial relevant factors of gestational diabetes mellitus [J]. Prog Obstet Gynecol, 2012, 21(3): 166-171.
- [10] 冯瑞, 邵红梅, 朱红, 等. 妊娠期糖尿病危险因素的 Meta 分析 [J]. 中国妇幼保健, 2014, 17(29): 2824-2827.
FENG R, SHAO H M, ZHU H, et al. Meta-analysis of risk factors of gestational diabetes mellitus [J]. Maternal & Child Health Care of China, 2014, 17(29): 2824-2827.
- [11] 章孟星, 周英凤, 钟婕, 等. 妊娠期糖尿病临床护理实践指南的整合研究 [J]. 中华护理杂志, 2019, 54(1): 104-113.
ZHANG M X, ZHOU Y F, ZHONG J, et al. The adaptation of clinical nursing practice guideline for gestational diabetes mellitus [J]. Chinese Journal of Nursing, 2019, 54(1): 104-113.
- [12] IOM. Clinical practice guidelines we can trust [M]. Washington DC: The national Academies Press, 2011: 1.
- [13] 靳英辉, 韩斐, 王明辉, 等. 临床实践指南制定方法——证据向推荐意见的转化 [J]. 中国循证心血管医学杂志, 2018, 10(9): 1031-1038.
JIN Y H, HAN F, WANG M H, et al. Methodology for clinical practice guidelines—evidence to recommendation [J]. Chin J Evid Based Cardiac Med, 2018, 10(9): 1031-1038.
- [14] QASEEM A, FORLAND F, MACBETH F, et al. Guidelines international network: toward international standards for clinical practice guidelines [J]. Annals of Internal Medicine, 2012, 156(7): 525-532.
- [15] 陈耀龙, 陈慧, 叶志康, 等. 中国万古霉素治疗药物监测指南的制订 [J]. 中国循证医学杂志, 2015, 15(2): 236-239.
CHEN Y L, CHEN K, YE Z K, et al. Development of Chinese practice guidelines on therapeutic drug monitoring of vancomycin [J]. Chin J Evid-based Med, 2015, 15(2): 236-239.
- [16] PEARSON A, WIECHULA R, COURT A, et al. The JBI model of evidence-based healthcare [J]. Int J Evid Based Healthc, 2005, 3(8): 207-215.

(收稿日期: 2019-12-19; 修回日期: 2020-09-30)

(本文编辑 张建华)